ORIGEM DO DOCUMENTO:	Núcleo de Segurança do Paciente		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Meta 3 - Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos			PRT.NSP.002
DATA 1º VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**DATA 1º VERSÃO**	**DATA DESTA VERSÃO**
10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025

1. OBJETIVO

Estabelecer e normatizar os procedimentos para prescrição, dispensação e administração de medicamentos reduzindo a possibilidade de falhas relacionadas ao uso de medicamentos.

2. ABRANGÊNCIA

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos deverá ser aplicado em todos as Enfermarias, Serviços de Urgência/Emergência, UTI's, Centro cirúrgico, Serviços de Radioterapia, Quimioterapia e Diagnóstico que prestam cuidados à saúde, em todos os níveis de complexidade, em que medicamentos sejam utilizados para profilaxia, exames diagnósticos, tratamento e medidas paliativas.

3. RESPONSÁVEL

3.1. Atribuições da Gestão

- Fornecer tecnologias em saúde para prescrição eletrônica;
- Fornecer os medicamentos necessários ao tratamento clínico adequado do paciente;
- Fornecer equipamentos médico-hospitalares de boa qualidade, como bombas de infusões contínuas e bombas de seringa para a administração de medicamentos que requerem alta precisão, seja pelo baixo volume a ser infundido ou pela característica da droga, como drogas vasoativas, sedativas, nutrição parenteral, entre outras;

- Disponibilizar local específico para preparo do medicamento mantido em boas condições de higiene, limpeza, iluminação, ventilação, além de mobiliário e estrutura que facilitem essas ações e a postura corporal;
- Incentivar e fornecer meios para promoção à educação permanente sobre o uso seguro de medicamentos, de forma periódica ou conforme a necessidade.
- Manter farmacêuticos e auxiliares de farmácia em número suficiente para permitir a dispensação segura de medicamentos.

3.2. Atribuições da Equipe Multidisciplinar

- Cumprir o Protocolo definido para Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, na totalidade dos pacientes assistidos na Instituição.

3.3. Atribuições do médico

- Prescrever ao paciente em prescrição eletrônica ou manual, que conste a identificação do prescritor, de forma legível, com número de registro do devido conselho profissional, podendo ser manuscrito ou utilização de carimbo, com a respectiva assinatura;
- Elaborar prescrições completas contendo minimamente os seguintes itens: Posologia, diluição, velocidade, tempo de infusão e via de administração;
- Conhecer a história clínica do paciente e utilizar medicamentos atualizados e baseados nos melhores níveis de evidência científica;
- Registrar com destaque na prescrição as alergias relatadas pelo paciente e/ou familiares;
- Limitar as prescrições verbais somente em situações de urgência e emergência;
- Realizar e manter atualizada a justificativa de solicitação de antimicrobianos via sistema eletrônico.

3.4. Atribuições do Farmacêutico

- Auxiliar na padronização de medicamentos na Instituição de Saúde através da participação na Comissão de Farmácia e Terapêutica;
- Assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao paciente no tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, químicas e microbiológicas;
- Seguir as diretrizes municipais de aquisição/compras de materiais e medicamentos, conforme estipulado pela SAF (Serviço de Atenção Farmacêutica);
- Assegurar o armazenamento e identificação adequados dos medicamentos, de modo a garantir a rastreabilidade até o uso pelo paciente;
- Analisar as prescrições médicas antes de sua dispensação e executar as intervenções necessárias;
- Participar ativamente das Comissões Hospitalares;
- Divulgar Tabela de Diluição de Medicamentos Injetáveis e padronizar uso destes medicamentos na Instituição, de modo a diminuir os riscos de Interações Medicamentosas por uso de substâncias não compatíveis;
- Fornecer lista de medicamentos com nomes semelhantes na grafia ou som para facilitar sua diferenciação nas etapas do sistema de medicamentos;
- Divulgar lista de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância padronizados para uso no Hospital;
- Alertar sobre os cuidados específicos de alguns medicamentos como necessidade de refrigeração, fotossensibilidade e interações medicamentosas;
- Estabelecer Procedimentos que garantam a dispensação correta aos pacientes e minimizem os erros de administração dos medicamentos;
- Implementar Serviço de Farmacovigilância e garantir que os eventos adversos a medicamentos sejam tratados conforme definido pela Instituição;
- Solucionar dúvidas diretamente com o prescritor e demais membros da equipe multiprofissional;
- Implementar este documento junto a equipe multiprofissional e assegurar a disponibilização em caso de novas versões do mesmo;
- Monitorar e analisar os indicadores relacionados a este protocolo.

3.5. Atribuições do Enfermeiro e/ ou técnico de enfermagem

- Seguir código de ética dos profissionais da enfermagem, principalmente no que tange as proibições dos artigos:
- o Art. 30 – Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos;
- o Art. 32 – Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa;
- Preparar, administrar e monitorar os medicamentos, considerando os nove certos em sua prática.
- Assinalar Alergias medicamentosa na Placa de Identificação de Riscos Assistenciais e identificar o medicamento no prontuário do paciente;
- Certificar-se das melhores evidências para administração dos fármacos.

4. MATERIAIS E RECURSOS

Não se aplica.

5. ETAPAS DO PROCESSO

5.1 PRÁTICAS SEGURAS PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

As prescrições, quanto ao tipo, classificam-se como:

a) **Urgência/emergência**: quando indica a necessidade do início imediato de tratamento. Geralmente possui dose única;

b) ***Pro re nata* ou caso necessário**: quando o tratamento prescrito deve ser administrado de acordo com uma necessidade específica do paciente, considerando-se o tempo mínimo entre as administrações e a dose máxima;

c) **Baseada em protocolos**: quando são preestabelecidas com critérios de início do uso, decurso e conclusão, sendo muito comum em quimioterapia antineoplásica;

d) **Padrão**: aquela que inicia um tratamento até que o prescritor o interrompa;

e) **Padrão com data de fechamento**: quando indica o início e fim do tratamento, sendo amplamente usada para prescrição de antimicrobianos em meio ambulatorial; e

f) **Verbal**: utilizada em emergências, sendo escrita posteriormente, em decorrência, possui elevado risco de erros e deverá ser restrita às situações para as quais é prevista.

Quanto à origem, a prescrição de medicamentos pode ser ambulatorial, hospitalar ou proveniente de outro estabelecimento de saúde.

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON), é padronizada a utilização de prescrições realizadas exclusivamente por meio do sistema informatizado institucional (SALUX), com o objetivo de assegurar legibilidade, rastreabilidade, padronização das informações e redução de erros relacionados à prescrição manual.

5.1.1 Itens de verificação para a prescrição segura de medicamentos

a) Identificação do paciente

A identificação correta do paciente na prescrição é requisito essencial para a segurança do uso de medicamentos. Prescrição ambulatorial: deve conter, no mínimo:

- Nome completo do paciente;
- Endereço;
- Data de nascimento.

Prescrição hospitalar: deve ser realizada em formulário institucional, por meio do sistema SALUX, e conter, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome da instituição;
- Nome completo do paciente;
- Nome completo da mãe;
- Data de nascimento;

- Número do prontuário ou registro do atendimento;
- Leito;
- Serviço;
- Enfermaria;
- Andar/Ala.

Observação: Todos os campos de identificação do paciente, tanto nas prescrições ambulatoriais quanto hospitalares, devem estar completamente preenchidos e legíveis, não sendo permitidas abreviações ou omissões.

A identificação do paciente na prescrição deve utilizar o nome completo do paciente como identificador principal, associado obrigatoriamente ao nome completo da mãe e à data de nascimento, em conformidade com o Protocolo Institucional de Identificação do Paciente (Meta 1) e com as diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente

b) Identificação do prescritor

A identificação do prescritor é obrigatória e indispensável para garantir a autenticidade, a rastreabilidade e a segurança da prescrição de medicamentos. A prescrição deve conter, obrigatoriamente o nome completo do prescritor, número de registro no respectivo conselho profissional e assinatura.

Nas prescrições manuais, utilizadas exclusivamente em situações de contingência, a identificação do prescritor deverá ser realizada por meio de assinatura manuscrita, podendo ser complementada por carimbo contendo os dados profissionais, desde que todos os elementos estejam legíveis.

Nas prescrições eletrônicas, realizadas por meio do sistema institucional SALUX, a identificação do prescritor ocorre por meio de assinatura eletrônica, vinculada ao login e senha de acesso ao sistema. O login e a senha de acesso ao sistema SALUX são de uso pessoal e intransferível, sendo o prescritor integralmente responsável por todas as prescrições realizadas sob sua identificação, conforme normas institucionais de segurança da informação.

Em qualquer modalidade de prescrição, a identificação do prescritor deverá estar claramente legível, de forma a permitir a conferência da autoria, assegurar a validade do documento e apoiar os processos de checagem, dispensação e administração segura dos medicamentos.

c) Identificação da instituição

Na prescrição ambulatorial e hospitalar deverá constar a identificação completa do estabelecimento de saúde (nome, endereço completo e telefone), para que o paciente possa manter contato com os profissionais de saúde para esclarecimentos de dúvidas posteriores à consulta.

d) Data da prescrição

A data da prescrição é imprescindível para conferir validade à mesma. Em meio ambulatorial, a validade da prescrição deve ser definida e registrada na própria prescrição, pelo prescritor. A data na prescrição é imprescindível para a dispensação e a administração dos medicamentos, assegurando-se de que o que foi indicado está baseado na avaliação médica do dia em que foi emitida a prescrição. A supressão da data na prescrição está relacionada à ocorrência de vários erros de medicação, entre eles a permanência da utilização de medicamentos por tempo inadequado e a administração de medicamentos sem indicação para a condição clínica atual do paciente.

e) Denominação do medicamento (DCB)

Os medicamentos devem ser prescritos utilizando-se a Denominação Comum Brasileira (DCB) e em sua ausência a Denominação Comum Internacional (DCI). Quanto à denominação de fitoterápicos, observar a determinação da Denominação Comum Brasileira de Fitoterápicos ou, quando omisso, utilizar a denominação botânica acrescida da parte da planta utilizada.

A utilização de códigos ou codinomes utilizados para medicamentos durante a fase de ensaios clínicos não devem ser utilizados para nominar medicamentos utilizados em estabelecimentos de saúde. Quando prescrito medicamento objeto de ensaio clínico, este deve ser identificado como tal, a partir do emprego da expressão “ensaio clínico”.

f) Medicamentos com nomes semelhantes (LASA)

Medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na instituição devem ser prescritos com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia, e pode ser utilizada letra maiúscula ou negrita. Exemplos de nomes semelhantes:

- **DOPA**mina e **DOBU**tamina;
- Clorpro**PAMIDA** e Clorpro**MAZINA**;
- Vim**BLAST**ina e Vin**CRIS**tina.

Na FCECON, esta lista foi elaborada contendo os medicamentos registrados no Brasil, considerando-se a Denominação Comum Brasileira (DCB). O objetivo foi elaborar uma relação de pares de nomes de medicamentos com grafia ou som semelhantes, com letras maiúsculas, de forma a facilitar práticas dirigidas a reduzir erros por confusão entre nomes de medicamentos, estabelecendo esta lista padrão para uso no cadastro dos medicamentos em sistemas informatizados, na etiquetação (ANEXO 2) e embalagem, na identificação nos locais de armazenamento e na divulgação da padronização, revisando-a anualmente.

ANEXO 1 - Lista Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspecto semelhantes.

g) Padronização de medicamentos

A FCECON dispõe de uma Relação de Medicamentos Padronizados, elaborada com base em critérios de efetividade, segurança e custo, alinhada ao perfil assistencial da instituição. Essa relação encontra-se disponível a todos os profissionais de saúde e está organizada por especialidade, favorecendo a familiaridade dos prescritores quanto às indicações, contraindicações, doses, reações adversas e demais informações relevantes.

Os medicamentos padronizados estão integralmente cadastrados no sistema informatizado institucional (SALUX), utilizado para a elaboração das prescrições e demais registros assistenciais. A prescrição de medicamentos padronizados contribui para o uso seguro, uma vez que amplia a familiaridade das equipes multiprofissionais com os fármacos, além de favorecer a rastreabilidade, a gestão de estoques e a política de aquisição da instituição.

A utilização do sistema informatizado para prescrição de medicamentos é obrigatória na FCECON, exceto em situações de contingência, devidamente normatizadas. O sistema informatizado contribui para a redução de erros relacionados à legibilidade, padroniza informações essenciais da prescrição e apoia a tomada de decisão clínica.

h) Estrutura obrigatória da prescrição de medicamentos

Para garantir a segurança do paciente e a efetividade do tratamento, toda prescrição de medicamentos deve conter informações completas, claras e padronizadas, permitindo a correta análise farmacêutica, dispensação e administração.

Recomenda-se que os medicamentos devam ser prescritos conforme estrutura a seguir:

ESTRUTURA DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS
USO ORAL
Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + posologia + via de administração + orientações de uso
Exemplo: captopril 25mg comprimido. Administrar 50mg de 8/8h por via oral, 1h antes ou 2h depois de alimentos.
USO TÓPICO
Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + via de administração + posologia + orientações de uso
Exemplo: Permanganato de potássio 1:60.000 solução. Aplicar compressas em membro inferior direito 3 vezes/dia, após o banho.
USO ENDOVENOSO
Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + via de administração + velocidade de infusão + posologia + orientações de administração e uso
Exemplo: anfotericina B 50mg frasco-ampola. Reconstituir 50mg em 10mL de água destilada e rediluir para 500mL de solução glicosada 5%. Uso endovenoso. infundir 35 gotas/min., 1 vez/dia. Administrar em 5 horas.

USO INTRAMUSCULAR
Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + via de administração + posologia + orientações de administração e uso
Exemplo: intramuscular com diluição**:** ceftriaxona 1g, frasco-ampola. Diluir 1g em 3,5 mL de lidocaína 1%. Fazer a solução obtida, via intramuscular profunda (região glútea) de 12/12h; intramuscular sem diluição: vitamina K (fitomenadiona) 10mg/mL, ampola. Fazer 1mL via intramuscular profunda (região glútea), 1x ao dia.
USO SUBCUTÂNEO
Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + volume + via de administração + posologia + orientações de administração e uso
Subcutâneo sem diluição: heparina sódica 5.000 unidades internacionais/0,25mL, ampola. Fazer 0,25mL subcutânea de 12/12h.
USO INTRATECAL
Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + dose + diluente + volume + via de administração + posologia + orientações de administração e uso
Uso Intratecal com diluição: citarabina 100mg, frasco-ampola. Diluir 100mg em 5mL de solução fisiológica 0,9%. Infundir 1,5mL intratecal, 1x/dia. Diluir imediatamente antes do uso. **Não reaproveitar o restante da solução para uso intratecal**.
USO INALATÓRIO
Nome do medicamento + concentração + forma farmacêutica + via + dose (medicamento e diluente) + posologia + orientação de uso.
Exemplo: bromidrato de fenoterol 5mg/mL, solução para inalação. Fazer aerosol com 5 gotas diluídas em 3 mL de solução fisiológica 0,9% de 6/6h. Nebulizar e inalar até esgotar toda a solução.

Fonte: Ministério da Saúde.

Nas prescrições eletrônicas, recomenda-se que o cadastro do medicamento permita apenas a seleção das vias de administração reconhecidas na literatura e descritas pelo fabricante, reduzindo o risco de erro por via incorreta.

Em prescrições ambulatoriais, além dos itens acima, devem constar orientações claras ao paciente quanto ao modo de uso do medicamento, incluindo recomendações não farmacológicas, quando pertinentes.

Todas as informações da prescrição devem estar expressas de forma inequívoca, sem uso de termos ambíguos ou incompletos, garantindo a compreensão por todos os profissionais envolvidos no processo assistencial.

i) Expressão de doses

As doses dos medicamentos devem ser expressas exclusivamente utilizando o sistema métrico, de forma clara e padronizada, a fim de reduzir o risco de erros de medicação.

Não devem ser utilizadas unidades de medida não métricas, como colher, ampola ou frasco, quando empregadas isoladamente para expressar a dose prescrita. Quando a forma farmacêutica (ampola, frasco-ampola, comprimido, cápsula ou outras) for mencionada, esta deve estar acompanhada de todas as informações necessárias para a correta dispensação e administração do medicamento.

A unidade de medida deve estar claramente indicada. No caso de microgramas, a unidade deverá ser escrita por extenso (“microgramas”), evitando abreviações que possam gerar confusão.

Ao prescrever doses ou volumes com números fracionados, deve-se assegurar que a vírgula esteja bem posicionada e legível, evitando interpretações equivocadas que possam resultar em erro de dose. Não deve ser utilizado ponto em substituição à vírgula.

Recomenda-se evitar o uso de zero antes da vírgula ou do ponto para expressar concentrações, pois pode gerar erro de interpretação e resultar em aumento indevido da dose. Sempre que possível, a dose deve ser expressa em unidades inteiras, priorizando-se, por exemplo, a prescrição de “500 mg” em vez de “0,5 g”.

As informações referentes à dose devem ser consistentes em todas as vias da prescrição e compatíveis com as apresentações e concentrações disponíveis na instituição.

j) Cálculo e conferência das doses

O cálculo das doses de medicamentos constitui etapa crítica do processo de prescrição e representa importante fator de risco para a ocorrência de erros de medicação, devendo ser realizado com atenção e conferido pelo prescritor antes da finalização da prescrição.

As doses devem ser prescritas de acordo com a melhor evidência científica disponível, respeitando as recomendações de bula, protocolos clínicos, diretrizes institucionais e limites máximos de segurança.

Para medicamentos cuja dose dependa de características individuais do paciente, como peso corporal, superfície corporal ou função renal e hepática, essas informações devem constar obrigatoriamente na prescrição ou estar registradas de forma acessível no prontuário, a fim de subsidiar a análise farmacêutica e a administração segura pela equipe de enfermagem.

A FCECON prioriza, sempre que possível, a utilização de medicamentos em apresentações prontas para uso ou em sistema de dose unitária, reduzindo a necessidade de manipulação prévia e, consequentemente, o risco de erros.

As doses prescritas, especialmente de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, devem ser submetidas à dupla checagem, realizada na fase de análise farmacêutica e reforçada no momento do recebimento e da administração pela equipe de enfermagem, conforme protocolos institucionais.

Em prescrições ambulatoriais, deverá constar a quantidade total de unidades farmacêuticas necessárias para o tratamento proposto, observando-se os limites estabelecidos pela legislação vigente.

k) Posologia

A posologia do medicamento deve ser prescrita de forma clara, completa e objetiva, contemplando a dose, o intervalo entre as administrações e a frequência diária, de acordo com as recomendações da literatura científica, diretrizes clínicas e protocolos institucionais vigentes.

Sempre que possível, recomenda-se a prescrição de esquemas terapêuticos com menor número de doses diárias, desde que clinicamente adequado, a fim de favorecer a adesão ao tratamento e reduzir o risco de erros na administração dos medicamentos.

A posologia prescrita deve respeitar as doses máximas recomendadas para cada medicamento, considerando as características clínicas do paciente, como idade, peso, função renal e hepática, bem como comorbidades associadas.

Nos casos em que o medicamento for prescrito em regime de uso “se necessário”, a posologia deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, da indicação clínica, da dose por administração, do intervalo mínimo entre as doses e da dose máxima diária permitida.

A posologia deve ser compatível com a via de administração prescrita e com as apresentações e concentrações disponíveis na instituição, permitindo a dispensação e administração seguras.

I) Duração do tratamento

A prescrição deve conter, de forma clara e objetiva, a duração prevista do tratamento medicamentoso, com o objetivo de evitar o uso prolongado ou contínuo de medicamentos sem indicação clínica adequada.

A definição do tempo de tratamento é essencial para a segurança do paciente, para o uso racional de medicamentos e para a prevenção de eventos adversos, resistência microbiana e desperdício de recursos.

Em prescrições ambulatoriais, especialmente para medicamentos de uso crônico, deve ser estabelecido um período de tratamento ou a data para reavaliação clínica, não sendo recomendada a prescrição sem prazo definido.

As expressões “uso contínuo”, “usar sem parar” ou similares, sem definição de tempo ou reavaliação, não devem ser utilizadas em prescrições ambulatoriais.

Em prescrições hospitalares, a duração do tratamento deve estar alinhada ao diagnóstico, à evolução clínica do paciente e aos protocolos institucionais, sendo reavaliada periodicamente pela equipe assistencial, com apoio da Farmácia Clínica quando aplicável.

m) Via de administração

A via de administração do medicamento deve ser prescrita de forma clara, completa e inequívoca, utilizando terminologia padronizada e compatível com as recomendações do fabricante, literatura científica e protocolos institucionais.

A definição correta da via de administração é fundamental para garantir a efetividade terapêutica, prevenir eventos adversos e evitar erros de medicação, especialmente aqueles relacionados à administração por via incorreta.

Em prescrições eletrônicas, deve-se priorizar a seleção da via de administração a partir de campos padronizados do sistema, evitando a digitação livre, de modo a reduzir o risco de erro.

A prescrição deverá conter apenas vias de administração autorizadas e compatíveis com o medicamento prescrito, sendo vedada a utilização de abreviaturas não padronizadas.

Nos casos em que o medicamento apresentar restrições ou alertas específicos quanto à via de administração (ex.: uso exclusivo por via endovenosa, contraindicação por outras vias), essa informação deve ser claramente observada e respeitada em todas as etapas do processo assistencial.

n) Diluição e volume

A prescrição deverá conter de forma clara e completa as informações referentes à reconstituição e/ou diluição do medicamento, incluindo obrigatoriamente: tipo de diluente, volume do diluente e volume final da solução a ser administrada.

A ausência ou imprecisão dessas informações pode comprometer a estabilidade, segurança e efetividade do medicamento, além de aumentar o risco de erro de preparo e administração.

A diluição deve seguir as recomendações do fabricante, literatura técnico-científica e protocolos institucionais vigentes, respeitando as condições de estabilidade, compatibilidade e segurança do paciente.

Sempre que possível, a prescrição deverá utilizar soluções padronizadas pela instituição, contribuindo para a redução da variabilidade do preparo, aumento da segurança do processo e otimização de recursos.

Nos casos em que a diluição ou o volume estejam diretamente relacionados à condição clínica do paciente (ex.: restrição hídrica, insuficiência renal ou cardíaca), essa necessidade deve ser considerada pelo prescritor e explicitada na prescrição.

o) Velocidade e tempo de infusão

Quando o medicamento for administrado por via endovenosa ou outra via que exija controle de infusão, a prescrição deverá especificar claramente a velocidade e/ou o tempo total de infusão, de forma a garantir a segurança e a efetividade do tratamento.

A definição da velocidade de infusão deve observar:

- as recomendações do fabricante;
- a melhor evidência científica disponível;
- os protocolos institucionais; e
- as condições clínicas do paciente.

A omissão dessas informações pode resultar em reações adversas preveníveis, como eventos relacionados à infusão rápida (ex.: síndrome do homem vermelho associada à vancomicina), além de erros de administração.

Sempre que aplicável, a velocidade deve ser expressa de forma objetiva (ex.: mL/h, gotas/minuto ou tempo total de infusão), evitando interpretações ambíguas.

Nos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, a conferência da velocidade e do tempo de infusão deve receber atenção especial, com reforço das etapas de checagem pela farmácia e pela enfermagem.

p) Registro de alergias

Deve-se registrar com destaque na prescrição as alergias relatadas pelo paciente, familiares e/ou cuidadores. O registro do relato de alergia na prescrição subsidia adequada análise farmacêutica das prescrições e os cuidados de enfermagem, reduzindo, assim, a chance da dispensação e administração de medicamento ao qual o paciente é alérgico. As alergias do paciente devem ser registradas no sistema eletrônico e constar em todas as prescrições emitidas para o paciente.

q) Outras informações importantes para o uso seguro

Para garantir o uso seguro e racional dos medicamentos, o prescritor deve considerar a história clínica do paciente, os medicamentos em uso e as condições clínicas atuais, conciliando essas informações com a nova prescrição, a fim de evitar duplicidades terapêuticas, interações medicamentosas, doses inadequadas e outras discrepâncias.

Sempre que necessário, o prescritor deve utilizar fontes de informação atualizadas e baseadas em evidências científicas para apoiar a tomada de decisão terapêutica, podendo contar com o suporte do farmacêutico clínico durante o processo de prescrição.

Nas prescrições ambulatoriais, quando aplicável, deve ser registrado o tempo de permanência do paciente em observação após a administração do medicamento, especialmente em situações de maior risco de reações adversas.

A ocorrência ou suspeita de reações adversas a medicamentos, erros de medicação ou eventos adversos relacionados ao processo assistencial deve ser prontamente notificada ao Núcleo de Segurança do Paciente/Gerência de Riscos da instituição, conforme fluxos institucionais estabelecidos.

É fundamental garantir que o paciente e/ou cuidador compreendam as informações da prescrição, incluindo orientações de uso, riscos e medidas de prevenção, por meio de ações colaborativas entre prescritores, farmacêuticos e equipe de enfermagem.

As atividades clínicas do farmacêutico devem ser incentivadas, considerando sua contribuição comprovada na redução de erros de prescrição, promoção do uso seguro de medicamentos e melhoria dos desfechos clínicos, em consonância com as boas práticas nacionais e internacionais de segurança do paciente.

r) Legibilidade

Problemas na legibilidade da prescrição podem comprometer a comunicação entre prescritor e paciente e entre prescritor e demais profissionais de saúde, sendo geradora importante de erros de medicação, sobretudo, a troca de medicamentos com nomes parecidos. Quando a prescrição possui medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância, os erros ocasionados pela legibilidade inapropriada podem ser graves, e até fatais.

Nesta Fundação é padronizada a utilização de prescrições feitas pelo Programa Informatizado Padrão em vigor como forma de melhorar a legibilidade das mesmas.

O uso de impressão frente e verso para prescrição não é recomendado, pelo elevado risco de omissão (não cumprimento integral da prescrição).

A utilização de prescrição pré-digitada é uma opção que pode diminuir alguns tipos de erros de medicação. A prescrição manual pode levar a elevado número de erros, ainda que parte delas possa ser legível. A prescrição carbonada não é recomendada.

É preciso, ainda, atenção aos novos tipos de erros de prescrição, que podem ser ocasionados devido à alteração na forma de prescrição (manuscrita, digitada, pré-digitada e eletrônica).

s) Uso de abreviaturas

Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos sem o uso de abreviaturas, pois seu uso aumenta a chance de erro de medicação. As abreviaturas “U” e “UI” significando “unidades” e “unidades internacionais”, respectivamente, são consideradas as mais perigosas de todas, pois podem levar à administração de doses 10 ou 100 vezes maior do que a prescrita 24-26. Desta maneira, deve-se abolir o uso de abreviaturas “U” e “UI”, escrevendo a palavra “unidade” por extenso no lugar de “U” ou “unidade internacional” no lugar de “UI”

t) Utilização de expressões vagas

Expressões vagas como “usar como de costume”, “usar como habitual”, “a critério médico”,“se necessário” (sem indicação de dose máxima, posologia e condição de uso), “uso contínuo” e “não parar” devem ser abolidas das prescrições.

Quando for preciso utilizar a expressão “se necessário”, deve-se obrigatoriamente definir:

- Dose;
- posologia;
- dose máxima diária deve estar claramente descrita; e
- condição que determina o uso ou interrupção do uso do medicamento.

Exemplo: paracetamol comprimido de 500mg uso oral. Administrar 500mg de 6 em 6h, se temperatura igual ou acima de 37,5ºC. Dose máxima diária 2 gramas (quatro comprimidos de 500mg).

5.1.2. Modificação da prescrição vigente

Qualquer alteração, suspensão ou inclusão de medicamentos na prescrição vigente deve ser realizada de forma clara, completa e sem rasuras, garantindo a segurança do processo de dispensação e administração.

Em prescrições hospitalares, as modificações devem ser efetuadas exclusivamente pelo prescritor, diretamente no sistema informatizado institucional. Quando, excepcionalmente, houver necessidade de prescrição manual em situação de contingência, as alterações devem ser realizadas em todas as vias da prescrição, devidamente datadas, identificadas e assinadas pelo prescritor.

Em prescrições ambulatoriais, não são permitidas rasuras ou alterações manuais. Caso seja necessária qualquer modificação na terapêutica, uma nova prescrição deverá ser emitida, sendo a anterior formalmente suspensa.

Todas as modificações realizadas devem estar registradas e rastreáveis, permitindo a adequada análise farmacêutica, a continuidade segura do cuidado e a comunicação efetiva entre os profissionais envolvidos no processo assistencial

5.1.3. Prescrições verbais

As prescrições verbais devem ser restritas às situações de urgência/emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da prescrição após a administração do medicamento. A prescrição verbal deve ser validada pelo prescritor assim que possível. Quando a ordem verbal for absolutamente necessária, o prescritor deve falar o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma clara. Quem recebeu a ordem verbal deve repetir de volta o que foi dito e ser confirmado pelo prescritor antes de administrar o medicamento, conforme técnica de readback do protocolo de comunicação efetiva.

Prescrição verbal realizada em (data) pelo Dr. (nome do médico), CRM (número), para (nome do paciente). Medicamento: (Nome do medicamento), dosagem XX mg, via de administração XX, frequência a cada XX horas duração do tratamento por XX dias, informações adicionais (alergias), profissional médico/enfermeiro (registrar nome completo e CRM/COREN). O mesmo repete a informação, confirmando o entendimento da prescrição informada.

Figura 1 - Modelo de registro para prescrição verbal.

5.1.4. Prescrição nos pontos de transição do cuidado

Na admissão do paciente para internação deverão ser relacionados quais medicamentos o paciente estava usando antes da internação, objetivando-se avaliar a necessidade da continuidade ou suspensão do uso dos mesmos (conciliação medicamentosa). Os pacientes devem ser orientados a não permanecerem com seus medicamentos na unidade hospitalar, em virtude do risco de utilização de doses duplicadas, quando administradas pela equipe de enfermagem e paralelamente por cuidador (acompanhante) ou pelo próprio paciente e ainda pelo risco do uso de medicamentos não indicados para a condição clínica atual do paciente, salvo os medicamentos prescritos e de uso necessário ao tratamento do paciente, que não compõem a padronização do hospital e cujo uso não acarretará em complicações ao tratamento. Em âmbito ambulatorial, chama-se de ponto crítico quando ocorre transição do paciente entre os níveis de atenção (primário, secundário ou terciário), sendo fundamental a realização dos encaminhamentos resolutivos entre as diferentes unidades de saúde e que a atenção básica seja a coordenadora do cuidado do usuário. Para tal, o prescritor deverá elaborar detalhado histórico farmacoterapêutico do paciente, podendo contar com a colaboração do farmacêutico, que deverá fazer a conciliação dos medicamentos.

Na transferência do paciente entre leitos, entre duas unidades de da mesma instituição hospitalar e entre instituições hospitalares distintas, as seguintes ações devem ser realizadas:

- Encaminhar resumo da internação e o prontuário atualizado e organizado (transferência interna), bem como resumo de alta (em caso de transferência externa, como forma de melhor orientar a nova equipe que prestará assistência ao paciente.

- O prescritor deverá elaborar detalhado histórico do plano terapêutico medicamentoso do paciente, podendo, para isso, contar com a participação do farmacêutico.

Importante:

- Os pontos de transição dos pacientes no hospital, da admissão à alta, ou mudança de local de internação, são considerados críticos, pois, frequentemente, nessas mudanças, ocorre expressivo número de erros de medicação, devido a informações incorretas ou incompletas sobre os medicamentos utilizados pelos pacientes, ocasionando principalmente a omissão ou duplicidade de dose.
- Nos pontos de transição, especialmente na alta hospitalar, o paciente deverá receber uma prescrição contendo todos os medicamentos de que fará uso e as recomendações necessárias à continuidade do tratamento, sendo recomendável a participação do farmacêutico com orientações para o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos.

5.1.5. Prescrição de medicamentos potencialmente perigosos / alta vigilância

Esta Fundação possui uma lista de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância que constam na relação de medicamentos selecionados, indicando as doses máximas desses medicamentos, a forma de administração (reconstituição, diluição, tempo de infusão, via de administração), a indicação e a dose usual.

O número de apresentações e concentrações disponíveis de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, especialmente anticoagulantes, opiáceos, insulina e eletrólitos concentrados (principalmente cloreto de potássio injetável), deve ser limitado.

As doses dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância deverão ser conferidas com dupla checagem na fase dos cálculos para prescrição e análise farmacêutica da prescrição para dispensação.

ANEXO 3 - Lista Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspecto semelhantes

5.1.6. Suporte eletrônico à prescrição

É de uso obrigatório a utilização do programa informatizado para prescrição de medicamentos com suporte clínico que está à disposição nesta Fundação e que fornece minimamente informações sobre:

- Doses máximas para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância e/ou com índice terapêutico estreito;
- Interações medicamentosas clinicamente significativas;
- Alergias;
- Apresentações e concentrações padronizadas disponíveis na instituição.

Importante:

Prescrições pré-digitadas podem aumentar a segurança no uso de medicamentos e devem ser adotadas.

Utilizar para impressão formulário sem pauta, pois as linhas podem encobrir pontos e vírgulas ou transformar “0” em “8”, aumentando, assim, a possibilidade de erros.

Quando se implantar novo sistema de prescrição na unidade de saúde (prescrições pré-digitadas, eletrônicas e outras), o prescritor, farmacêutico e enfermeiro devem acompanhar o processo de prescrição para identificar e corrigir erros decorrentes do uso do novo sistema.

Observação: Em caso de falha ou indisponibilidade do sistema, deve-se adotar o Plano de Contingência para Prescrição de Medicamentos.

5.2 PRÁTICAS SEGURAS PARA ARMAZENAMETO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

5.2.1. Seleção de medicamentos e PPS

O elenco de medicamentos e produtos para a saúde é definido a partir da padronização elaborada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica FCECON (CFT), promulgada pela Portaria 078/2016. A CFT é constituída por uma equipe multidisciplinar, representada por

membros gestores da instituição e profissionais de diferentes especialidades médicas como oncologia, hematologia, anestesiologia (ambulatório da dor), farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, entre outros.

Entre as atribuições principais dessa Comissão está a seleção de fármacos. A Relação de Medicamentos Antineoplásicos (REMAN) foi aprovada por meio da Portaria 079/2016. A referida norma prevê a padronização de antineoplásicos e adjuvantes da quimioterapia de forma a garantir seu uso seguro a partir de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia instituídos.

5.2.2. Gestão de medicamentos e PPS

Os medicamentos e produtos para a saúde (PPS) são programados para abastecimento da FCECON entre 3 e 6 meses, de acordo com o consumo médio de cada produto e com a Padronização de Medicamentos e PPS.

O controle do abastecimento é realizado pelo sistema de gestão hospitalar SALUX e que informatiza não somente o processo de atendimento aos pacientes, mas também gerencia o abastecimento de medicamentos e PPS. Esse gerenciamento é realizado por lote, validade, valor unitário, marca ou fabricante, conforme Instrução de trabalho 01 (IT 01 GEFAR/GERPA) relatado no tópico 4. Por meio do sistema, é possível programar a aquisição dos medicamentos e materiais, além de monitorar a dispensação dos medicamentos por paciente e autorizações por sistema de distribuição coletiva para os diversos setores da FCECON, garantindo a rastreabilidade.

5.2.3. Aquisição de medicamentos e Produtos para a saúde (PPS)

O processo de compra de medicamentos e PPS no setor público envolve um conjunto de exigências legais e administrativas que devem ser cumpridas. Todos os medicamentos são adquiridos de acordo com a Lei nº8.666/93, estando sob a responsabilidade do farmacêutico a elaboração da especificação técnica e informações para cadastramento, a emissão de pareceres técnicos nos processos de compra e a elaboração do planejamento das aquisições. O quantitativo adquirido corresponde às necessidades geradas pelo consumo dos medicamentos nas FCECON.

As normas que regulam os processos de aquisição na FCECON são as estabelecidas pela Lei8.666 de 06 de junho de 1993 que prevê as regras para licitação e “destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Lei nº 12.349/ 2010).”

Os medicamentos não padronizados, a partir da análise técnica da Comissão de farmácia e Terapêutica (CFT), se deliberado positivamente, são realizados os trâmites de aquisição pública, para que o medicamento seja adquirido. A solicitação é encaminhada ao setor de compras, com a anuência das Direções Clínica e Administrativa. Para estas solicitações são seguidas as instruções de trabalho 06 (IT 06 GEFAR06).

5.2.4. Dispensação de medicamentos e PPS

A dispensação é a principal atividade do ciclo da assistência farmacêutica na farmácia hospitalar, sendo definida como “ato do profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado” (Brasil, 1998). A dispensação deve ser realizada nas quantidades e especificações solicitadas, de forma segura e no prazo requerido, promovendo o uso adequado e correto de medicamentos e correlatos.

Na Farmácia Hospitalar FCECON o sistema de dispensação é individualizado, de forma direta e realizada para cada paciente internado. Neste sistema os medicamentos são dispensados mediante a apresentação da prescrição médica, onde as doses são atendidas para 24 horas, de acordo com a posologia médica.

A atividade de dispensação é registrada por meio sistema de gestão SALUX. Esse registro é realizado por paciente, indentificado pelo número de prontuário, quando ocorre de forma individualizada, onde se tem acesso à prescrição interna realizada pelo médico, com validade para 24 horas.

Para procedimentos realizados pelo ambulatório de especialidades, radioterapia, endoscopia, urgência (pronto atendimento), imagenologia, o sistema de distribuição de medicamentos pode se dá de forma coletiva, justificando-se a saída dos medicamentos por mapa de produção alcançada nestes setores.

No caso dos PPS, a dispensação também é realizada de forma coletiva pelo setor de almoxarifado. A enfermagem é responsável em gerir os materiais nos postos de enfermaria, solicitando os materiais de acordo com o cronograma de pedido e demanda, de acordo com número de leitos ocupados por setor.

5.2.5. Estratégias para dispensação segura relacionadas à prescrição

Realizar a análise farmacêutica das prescrições (Portaria GM/MS 4283/2010), priorizando aquelas que contêm antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, observando-se concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes, dose, dosagem, forma farmacêutica, via e horários de administração, devendo ser realizada antes do início da dispensação e manipulação.

Com base nos dados da prescrição, devem ser registrados os cálculos necessários ou à manipulação da formulação prescrita, verificando-se a aplicação dos fatores de conversão, correção e equivalência, quando for o caso, sendo checados e assinados pelo farmacêutico.

Recomenda-se, para auxílio ao farmacêutico no processo de análise da prescrição, a utilização de programa informatizado com suporte terapêutico que incorpore adequado conjunto de verificações automatizadas em prescrições, tais como:

- Triagem para duplicidade terapêutica;
- Alergias;
- Interações medicamentosas;
- Intervalos de dose adequados;
- Alerta para doses superiores às máximas;
- Alertas para nomes semelhantes, entre outros.
- Fontes de ruídos e distrações devem ser reduzidas (conversas) e eliminadas (televisão, música, uso de telefones celulares e fixos) no momento da análise e

dispensação dos medicamentos e o ambiente de dispensação deve ser restrito a essa atividade.

Preconiza-se adotar o uso de rótulos diferenciados, notas em sistema informatizado e cartazes de alerta no local de armazenamento e dispensação de medicamentos com elevada propensão a trocas.

Recomenda-se a implantação de sistemas seguros, organizados e eficazes de dispensação para reduzir a ocorrência de erros, privilegiando a dispensação por dose individualizada, com controle por código de barras ou equivalente superior, de modo a assegurar a rastreabilidade do lote, fabricante e validade dos medicamentos e produtos para a saúde.

Em farmácias ambulatoriais e hospitalares, as etapas de recebimento da prescrição, separação e dispensação dos medicamentos ao paciente devem ser realizadas com dupla conferência dos medicamentos em ambiente exclusivo para essa finalidade.

Deve-se elaborar e disponibilizar procedimentos operacionais atualizados para a dispensação de medicamentos, com destaque especial para os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.

A dispensação deve ser restringida por meio de ordem verbal exclusivamente para situações de urgência e emergência, devendo a prescrição do medicamento ser entregue na farmácia imediatamente após a normalização da situação que gerou a ordem. Nesses casos, o profissional da farmácia que ouviu a ordem verbal deverá repetir o que escutou para certificar-se da informação, procedendo à dispensação e registrando sua ocorrência em formulário específico.

5.2.6. Procedimento operacional padrão para dispensação de medicamentos

Para dispensação segura de medicamentos deve-se seguir os seguintes procedimentos:

- O farmacêutico deve analisar as prescrições antes do início da separação dos medicamentos, conferindo se todos os elementos de identificação da instituição, do paciente, do prescritor e a data estão disponíveis;

- Analisar os medicamentos prescritos, evitando que possíveis erros de prescrição se tornem erros de dispensação;
- Solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com o prescritor, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, caso ocorra a necessidade, por falha no sistema etc., de se prescrever de forma manual, eliminando interpretação ou dedução do que está escrito;
- Analisar os medicamentos prescritos considerando-se os seguintes aspectos:

✓ Dose, forma farmacêutica, concentração, via de administração, posologia, diluente, velocidade de infusão, tempo de infusão, indicação, contraindicação, duplicidade terapêutica, interação medicamento-medicamento e medicamento-alimento e possíveis alergias;

- O auxiliar de farmácia não deverá separar simultaneamente prescrições diferentes;
- Manter a organização do ambiente de dispensação, assegurando-se suficiente espaço e instrumentos de trabalho que permitam a manutenção dos medicamentos devidamente separados por prescrição e por paciente, até a sua dispensação, evitando-se que medicamentos prescritos e dispensados para um paciente sejam entregues a outros. Para essa finalidade poderão ser utilizados carros de medicação ou embalagens plásticas identificadas;
- Realizar a conferência dos medicamentos separados para dispensação, verificando se as informações disponíveis no rótulo dos medicamentos são iguais às da prescrição;
- Identificar os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância e fazer meticulosa revisão da prescrição e dispensação deles (vide relação de Medicamentos Potencialmente Perigosos Padronizados na FCECON em ANEXO 3);
- Verificar se existem medicamentos com nomes ou embalagens semelhantes na prescrição, dedicando especial atenção à conferência dos mesmos;
- Realizar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação, utilizando, sempre que possível, o auxílio de dispositivos eletrônicos, tais como código de barras;
- O farmacêutico deve revisar as prescrições de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância;

- Para a dispensação ambulatorial, realizar orientação e aconselhamento do paciente previamente à dispensação dos medicamentos, objetivando identificar e interceptar erros. Ao dispensar medicamentos para o paciente, conferir e identificá-los, especialmente aqueles de embalagem semelhante, usando identificadores que possam diferenciá-los, como, por exemplo, cores diferentes;
- Realizar o registro escrito, em prontuário, das intervenções farmacêuticas realizadas.
- Deve existir restrição formal e registro da dispensação de medicamentos por ordem verbal.
- Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância devem ser identificados de forma diferenciada dos medicamentos em geral no armazenamento e dispensação;
- A dupla checagem dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância dispensados deve ser feita na farmácia deste estabelecimento de saúde.

A dispensação dos itens deverá ser realizada por meio de uma etiqueta de identificação, conforme modelo, preenchida pelo colaborador da farmácia.

Assistência Farmacêutica

Data: ____/____/_____ Turno: 24 horas

Nome: _____

_____

Data de nascimento: _____/_____/_____

Registro Salux:_____

Setor: _____ Leito: _____

Avisos

Assistência Farmacêutica

Data: ____/____/_____ Turno: 24 horas

Nome: _____

Nome da Mãe_____

Data de nascimento: _____/_____/_____

Registro Salux:_____

Setor: _____ Leito: _____

Avisos

5.2.7. Dispensação e Controle de Validade de Medicamentos Multidoses

A dispensação dos medicamentos multidoses será realizada mediante a solicitação por requisição de materiais e medicamentos, de acordo com os itens padronizados no setor, e troca de embalagem vazia, entregue na farmácia.

Para os medicamentos multidoses que não são padronizados no setor e a equipe de enfermagem não possua o frasco vazio para troca, a dispensação deverá ocorrer somente por prescrição médica, entregue na farmácia.

Os medicamentos multidoses deverão ser identificados, conforme figura abaixo:

Validade Multidose

Data de Abertura: _____/_____/_____

Val. após aberto: _____/_____/_____

Ambiente ( ) Refrigerado ( )

A estabilidade dos medicamentos multidoses deverão corresponder a validade para cada medicamento após aberto, conforme informações fornecidas pela farmácia.

No primeiro uso, no momento da abertura, deve-se efetuar o cálculo de validade do produto após abertura e registrar na etiqueta afixada, conforme orientações descritas na tabela 01.

As validades das multidoses armazenadas nas unidades assistenciais deverão ser verificadas diariamente pela enfermagem e monitoradas mensalmente pelos farmacêuticos e as sobras de produtos vencidos e não mais utilizados deverão ser descartadas adequadamente

O controle da validade dos medicamentos e materiais médico-hospitalares, deve ser realizado mensalmente em todas as farmácias, sendo retirado o medicamento com vencimento no mês corrente e segregado na quarentena, na farmácia central. No último dia do final de cada mês os farmacêuticos relacionarão os medicamentos vencidos e procederão com as devidas baixas e descartes. A conferência de validade dos itens do carro de emergência será realizada mensalmente pela equipe de enfermagem de cada unidade, conforme descrito no Protocolo do Carro de emergência. Os farmacêuticos farão auditoria dos carros de emergência mensalmente, conforme cronograma prévio.

Para os medicamentos multidoses, deve-se considerar as validades após abertura conforme a tabela 01.

Produto	Validade pós-abertura
Pomadas, cremes e géis	30 dias
Gotas, xaropes e suspensões	30 dias
Lidocaína geleia	Uso único
Insulina	28 dias (Dependendo do fabricante, pode ter variação)
Almotolias (Soluções aquosa e degermante)	7 dias
Almotolias (Álcool à 70% e soluções alcoólicas)	

Tabela 02 - Validades após abertura dos medicamentos multidoses

5.2.8. Armazenamento e dispensação de Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância:

Os medicamentos que forem classificadas como Potencialmente Perigosos (MPP) ou de Alta Vigilância (MAV) deverão ser identificados com etiqueta vermelha com sinalização de atenção, como segue abaixo:



1. Identificar todos os Medicamentos de Alta Vigilância padronizados na FCECON, com base na lista divulgada pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP).

2. Criar lista com os MAV indicando a substância, a concentração, a classe terapêutica e as principais consequências da potencialidade de risco.

3. Definir quais MAVs serão etiquetados de vermelho.

4. Divulgar a lista dos MAVs que serão etiquetados de vermelho junto aos Setores de Dispensação, CAFs e Farmácias.

5. Identificar com etiquetas vermelhas todos os MAV conforme.



6. Definir local de armazenagem na Farmácia e CAFs diferenciando-os dos demais com uma tarja vermelha.



7. Segregar os Medicamentos de Alta Vigilância dos demais medicamentos:

7.1. Nos carros de emergência: Apor os MAVs em compartimentos específicos.



7.2 Nos kits cirúrgicos: Apor todos os MAVs em sacos plásticos transparentes e posteriormente apor o saco na caixa de medicamentos.

7.3 Nos kits anestesia: Apor todos os MAVs em sacos plásticos transparentes e identificar a parte externa da caixa com etiqueta vermelha.





7.4 Na geladeira: Apor os MAVs em caixas acrílicas identificadas com etiquetas vermelhas.

7.5 Nas farmácias, CAF e Almoxarifado: Segregar em locais distintos (prateleiras ou armários específicos identificados) dos demais medicamentos.

8. Identificar os eletrólitos (KCL 10%) em embalagens individuais e etiquetas vermelhas.



9. Realizar treinamento com os profissionais de saúde envolvidos na cadeia de utilização destes medicamentos.

10. Realizar dupla conferência independente em todos os processos de maior risco no hospital.

11. Cumprir o fluxo da cadeia de suprimentos desde o recebimento até a dispensação dos MAVs.

12. Estabelecer processos de auditorias periódicas para verificação das ações estabelecidas.

5.2.9. Medicamentos Termolábeis

Uma vez que os medicamentos termolábeis devem ser mantidos em refrigeração até momentos antes da administração para manutenção de sua estabilidade, a farmácia deve disponibilizar caixas de transporte para que os mesmos sejam levados até os leitos para administração, ou para armazenamento no refrigerador da sala de preparo de medicamentos. A equipe de farmácia deve disponibilizar caixas de isopor com gelox para transporte desses termolábeis. A caixa térmica disponível está destinada para transporte da Nutrição Parenteral. A equipe de enfermagem solicita previamente a caixa térmica ou caixas de isopor para retirada dos medicamentos, sendo responsável pela devolução da mesma. É de responsabilidade da Farmácia a realização de assepsia periódica das caixas com o respectivo registro.

5.2.10. Medicamentos Fotossensíveis

São medicamentos que ao serem expostos à luz, seja ela artificial ou solar, perdem suas propriedades farmacológicas, adquirindo coloração diferente. Para administração dos medicamentos fotossensíveis é necessário o equipo para proteção contraluz ou capa protetora. As equipes devem se atentar quando ao medicamento prescrito e sua necessidade de equipo fotossensível. A solicitação desses produtos deve ser solicitada nas farmácias satélites e central.

Todas as informações referentes aos medicamentos termolábeis e fotossensíveis estão contidas no POP de procedimentos para medicamentos termolábeis e fotossensíveis.

5.2.11. Devolução De Medicamentos

As devoluções devem ser realizadas diariamente ou conforme demanda do setor. Os horários previstos para as devoluções são: até às 10h da manhã preferencialmente ou após as 16h da tarde, horários de menor impacto com a análise das prescrições e separação das doses individualizadas.

Também é de suma importância que o estoque de medicamentos dos setores seja mantido devidamente organizado e em níveis mínimos, sempre atentando-se às validades. Com este objetivo a equipe de enfermagem deve solicitar racionalmente os medicamentos da dose coletiva e, se for o caso, sinalizar à equipe de farmacêuticos a necessidade ou não de envio de medicamentos SOS ou ACM na dose individualizada.

Vale ressaltar que nas transferências internas de pacientes os medicamentos já dispensados naquele dia, sobretudo antimicrobianos, devem ser transferidos JUNTO COM O PACIENTE para o próximo setor evitando assim possíveis descontinuidades de tratamento e retrabalhos de todas as equipes.

Tratando-se de medicamentos termolábeis a devolução será avaliada caso a caso pelo farmacêutico e enfermagem com o intuito de assegurar que houve o correto armazenamento no setor de origem da devolução.

Ao preencher o formulário de devolução interna de material (DIM), a equipe de enfermagem deve atentar para:

- Listar todos os medicamentos que estão sendo devolvidos pela sua denominação comum brasileira (DCB) ou nome genérico, sua forma farmacêutica, a quantidade devolvida, os lotes e as validades de cada item;
- Verificar se há conformidade entre a quantidade que está descrita e a que está sendo devolvida;
- Manter os itens devidamente ordenados e segregados pelo lote e validade;
- Zelar pelo correto armazenamento e transporte, respeitando as temperaturas, dos itens termolábeis;
- Carimbar e assinar a DIM no campo “Responsável pela Devolução”, preencher a clínica, os motivos para cada item a ser devolvido e a data da devolução;

Ao receber uma DIM, o farmacêutico ou profissional por ele indicado deve verificar se:

- Estão listados todos os medicamentos que estão sendo devolvidos, sua forma farmacêutica, a quantidade devolvida e se os lotes e as validades estão indicados;
- Verificar se há assinatura e matrícula do profissional que está devolvendo, sua clínica, motivo da devolução e a data da devolução;
- Verificar se há conformidade entre a quantidade que está descrita e a que está sendo devolvida;
- Carimbar e assinar (apenas o farmacêutico deve fazê-lo) a DIM após verificação e confirmação de conformidade;
- Colocar a DIM na pasta de movimentação do dia para ser posteriormente digitada;
- Solicitar ao oficial de farmácia a reposição dos medicamentos nas prateleiras.

5.2.12. Controle de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (Portaria 344/98)

O controle dos medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98), pode ser visualizado através do Sistema SALUX que contempla todas as movimentações realizadas (entrada, baixa para paciente, devolução, perda e etc.), e identificação dos pacientes para os quais foram dispensados. Para dispensação das prescrições manuais, a dispensação ocorre mediante receituário médico.

Além disso, há contagem do estoque desses medicamentos em cada plantão. Os medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria Nº 344/98) armazenados nos carros de emergência servem para atender intercorrências emergenciais dos setores, em que o tempo normal de atendimento e dispensação pode impactar no resultado assistencial, aumentando o risco de um evento indesejado.

No Centro cirúrgico são dispensados em maletas e registrado pelo médico (Prescrição).

Na UTI os farmacêuticos realizam a triagem das prescrições e calculam a quantidade de medicamentos a serem dispensados por prescrição de 24h. O medicamento é separado e acondicionado em local apropriado, contendo a identificação do paciente. Ao retirá-los na farmácia, a enfermagem (Enfermeiro/Técnico de enfermagem) assinam o checklist de controle de entrega, realizando uma dupla checagem na entrega dos mesmos. Qualquer dose adicional é dispensada mediante prescrição ou receita.

5.2.13. Controle de Antimicrobianos

O controle, avaliação e liberação do uso de antimicrobianos deve ser acompanhado pela CCIRAS. Assim, seguira o fluxo descrito no POP de Dispensação de Antimicrobianos de uso restrito:

a) Preenchimento da Solicitação: O médico assistente preenche a Solicitação de Uso de Antimicrobiano, informando os dados pessoais e clínicos do paciente. A ficha deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Identificação do paciente

- Justificativa para o uso do antimicrobiano
- Posologia
- Tempo de tratamento
- Indicação de uso terapêutico ou profilático

b) Envio para a Farmácia Central: A ficha é enviada à Farmácia Central, que confere se está devidamente preenchida e libera as primeiras doses do antimicrobiano. Caso esteja incompleta, a ficha é devolvida ao médico para adequação. O antimicrobiano não será liberado enquanto não forem fornecidas as informações mínimas necessárias para a avaliação da Farmácia Clínica e da CCIRAS.

Se o médico prescritor não estiver presente na instituição (por exemplo, em feriados ou finais de semana), a ficha poderá ser preenchida por um residente ou médico plantonista.

c) Avaliação pelo Farmacêutico: Após a conferência inicial, a ficha é encaminhada para avaliação do farmacêutico clínico, que realiza a triagem da prescrição, verificando os seguintes aspectos:

- Correção da posologia: checagem das doses e intervalos entre as administrações.
- Consistência das informações: caso haja inconsistências, o farmacêutico entra em contato com o médico prescritor para confirmação.
- Vigilância contínua: monitoramento da justificativa de uso e do tempo de tratamento, prevenindo o uso prolongado e a consequente seleção de bactérias resistentes.

Se a confirmação das informações não for possível, o antimicrobiano não será liberado, e a CCIH será imediatamente notificada para auxiliar na avaliação.

d) Análise da CCIRAS: A CCIRAS revisa a solicitação via sistema SALUX, avaliando a indicação clínica do antimicrobiano. Caso não haja inconsistências, a medicação é liberada conforme o tempo previsto de tratamento.

e) Divergência na Indicação do Antimicrobiano: Se houver discordância entre o antimicrobiano solicitado e a indicação clínica, o infectologista, em conjunto com a Farmácia Clínica, comunica-se com o médico assistente para discutir o caso e adequar a prescrição.

f) Atualização da Prescrição Médica: O médico prescritor deve atualizar diariamente os dias de uso do antimicrobiano na prescrição médica, garantindo que o tempo de uso esteja coerente com o solicitado na ficha inicial.

g) Solicitação para Prolongamento do Uso: Caso seja necessária a continuidade do antimicrobiano além do tempo inicialmente estipulado, o médico assistente deve preencher uma nova solicitação, que seguirá o mesmo fluxo de avaliação e liberação.



5.3. PRÁTICAS SEGURAS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

A administração de medicamentos é um processo multi e interdisciplinar, que exige conhecimento técnico e prática. Para a administração segura, são necessários conhecimentos sobre Farmacologia, Anatomia, Fisiologia, Microbiologia e Bioquímica.

A dimensão dos erros relacionados à administração de medicamentos foi apresentada em estudo realizado em 2006 em quatro hospitais brasileiros, tendo sido evidenciado que 1,7% dos

medicamentos administrados foi diferente dos medicamentos prescritos; 4,8% das doses administradas diferiam das prescritas; 1,5% dos medicamentos foi administrado em vias diferentes das prescritas; 0,3% dos pacientes recebeu medicamentos não autorizados ou não prescritos; quase 2,2% dos medicamentos foram administrados uma hora antes do previsto e 7,4% mais de uma hora depois do prescrito. A etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicação derivado dos processos de prescrição e dispensação, aumentando, com isso, a responsabilidade do profissional que administra medicamentos.

A equipe de enfermagem tem seguido tradicionalmente os cinco certos na administração de medicamentos. Recente artigo identifica nove certos para administração de medicamentos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa.

Os nove certos não garantem que os erros de administração não ocorrerão, mas segui-los pode prevenir significativa parte desses eventos, melhorando a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente durante o processo de administração de medicamentos.

5.3.1. Paciente Certo

Deve-se perguntar ao paciente seu nome completo antes de administrar o medicamento e utilizar no mínimo dois identificadores para confirmar o paciente correto (data de nascimento e nome da mãe). Nessa etapa, é importante que o profissional faça perguntas abertas e que necessitam de mais interação paciente-profissional, tal como: “Por favor, diga-me o seu nome completo? ”além disso, é importante verificar se esse paciente corresponde ao:

- Nome identificado na pulseira;
- Nome identificado no leito;
- Nome identificado no prontuário.

5.3.2. Medicamento Certo

- Conferir se o nome do medicamento que tem em mãos é o que está prescrito.

- O nome do medicamento deve ser confirmado com a prescrição antes de ser administrado.
- Conhecer o paciente e suas alergias. Conferir se ele não é alérgico ao medicamento prescrito.
- Identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada, com pulseira e aviso em prontuário, alertando toda a equipe.
- Todos os fatos descritos pelo paciente/cuidador ou observado pela equipe, sejam eles reações adversas, efeitos colaterais ou erros de medicação, devem ser registrados em prontuário e, notificados.

Importante: alguns medicamentos são associações. Nesses casos, é necessário conhecer a composição dos medicamentos para identificar se o paciente não é alérgico a algum dos componentes do medicamento.

5.3.3. Via Certa

- Identificar a via de administração prescrita
- Verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para administrar determinado medicamento.
- Lavar as mãos antes do preparo e administração do medicamento.
- Verificar se o diluente (tipo e volume) foi prescrito e se a velocidade de infusão foi estabelecida, analisando sua compatibilidade com a via de administração e com o medicamento em caso de administração por via endovenosa.
- Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde utilizados para sua administração (seringas, cateteres, sondas, equipes e outros).
- Identificar no paciente qual a conexão correta para a via de administração prescrita em caso de administração por sonda nasogástrica, nas a entérica ou via parenteral.

5.3.4. Hora Certa

- Preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração seja feita sempre no horário correto, para garantir adequada resposta terapêutica.
- Preparar o medicamento no horário oportuno e de acordo com as recomendações do fabricante, assegurando-lhe estabilidade.
- A antecipação ou o atraso da administração em relação ao horário predefinido somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro e do prescritor.
- Realizar a antissepsia do local da aplicação para administração de medicamentos por via parenteral.
- Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, prescritor ou farmacêutico previamente à administração do medicamento.
- Esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente como prescritor.
- Importante: Informações sobre compatibilidade de medicamentos e produtos para a saúde utilizados na administração de medicamentos, deverão estar disponíveis em manual ou em base de dados para consulta no local do preparo ou pode-se consultar o farmacêutico.

5.3.5. Dose Certa

- Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento.
- Doses escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses 10 ou 100 vezes superiores à desejada.
- Certificar-se de que a infusão programada é a prescrita para aquele paciente.
- Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de dúvida ou medidas imprecisas (colher de chá, colher de sopa, ampola), consultar o prescritor e solicitar a prescrição de uma unidade de medida do sistema métrico.

- Conferir a velocidade de gotejamento, a programação e o funcionamento das bombas de infusão contínua em caso de medicamentos de infusão contínua.
- Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de bombas para administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.
- Medicações de uso “se necessário” deverão, quando prescritas, ser acompanhadas da dose, posologia e condições de uso
- Solicitar complementação do prescritor em caso de orientações vagas, tais como “fazer se necessário”, “conforme ordem médica ”ou“ a critério médico”, para possibilitar a administração.

Importante: Não deverão ser administrados medicamentos em casos de prescrições vagas como: “fazer se necessário”, “conforme ordem médica” ou “a critério médico”.

5.3.6. Registro Certo Da Administração

- Registrar na prescrição o horário da administração do medicamento. Checar o horário da administração do medicamento a cada dose.
- Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais como adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusado paciente e eventos adversos.

Em caso de desabastecimento: caso ocorra desabastecimento, deverá ser registrado e o Serviço de Farmácia Hospitalar emitirá relatórios diários que deverão ser entregues com a medicação de 24 horas do paciente, sinalizando os medicamentos em situação de desabastecimento.

Ausência da medicação do paciente: Caso o medicamento do horário não esteja junto à medicação do paciente, sempre confirmar com o Serviço de Farmácia Hospitalar o motivo do não envio. Os motivos podem ser: ausência ou vencimento da justificativa de antimicrobianos da administração; notificações encaminhadas aos prescritores para correções e/ou alterações.

Sendo assim o responsável pela administração deve certificar-se com a farmácia o motivo, antes de omitir (não administrar), qualquer dose de medicamento prescrito não encaminhado.

5.3.7. Orientação Correta

- Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua posologia ou outra informação antes de administrá-lo ao paciente junto ao prescritor.
- Orientar e instruir o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado (nome), justificativa da indicação, efeitos esperados e aqueles que necessitam de acompanhamento e monitorização.
- Garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto (cor e formato) dos medicamentos que está recebendo, a frequência com que será ministrado, bem como sua indicação, sendo esse conhecimento útil na prevenção de erro de medicação.

5.3.8. Forma Certa

- Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e via administração prescrita.
- Checar se forma farmacêutica e a via de administração prescrita estão apropriadas à condição clínica do paciente.
- Sanar as dúvidas relativas à forma farmacêutica e a via de administração prescrita junto ao enfermeiro, farmacêutico ou prescritor.
- A farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou manual de diluição, preparo e administração de medicamentos, caso seja necessário realizar a trituração e suspensão do medicamento para administração por sonda nasogástrica ou nasoentérica.

5.3.9. Resposta Certa

- Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando possível, se o medicamento teve o efeito desejado.
- Registrar em prontuário e informar ao prescritor, todos os efeitos diferentes (em intensidade e forma) do esperado para o medicamento.
- Deve-se manter clara a comunicação como paciente e/ou cuidador.
- Considerar a observação e relato do paciente e/ou cuidador sobre os efeitos dos medicamentos administrados, incluindo respostas diferentes do padrão usual.
- Registrar todos os parâmetros de monitorização adequados (sinais vitais, glicemia capilar).

5.3.10. Intervenções Específicas

- Instituir a prática de dupla checagem por dois profissionais, para os cálculos de diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância.
- Remover do estoque das unidades de internação os eletrólitos concentrados (especialmente cloreto de potássio injetável) e bloqueadores neuromusculares.
- Deverão permanecer nas unidades de internação APENAS os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância que sejam absolutamente necessários à assistência ao paciente.
- Implementar a prática de verificação dos nove certos da terapia medicamentosa.
- Certificar-se de que as informações sobre o processo de medicação estejam documentadas corretamente.
- Somente administrar medicamentos se as dúvidas forem esclarecidas.
- Estabelecer protocolos institucionais de administração de medicamentos e atualizá- los periodicamente.

- Utilizar materiais e técnicas assépticas para administrar medicamentos por via intravenosa e para outras vias que exijam esse tipo de técnica.

- Registrar, conforme protocolo da instituição, todas as ações imediatamente após a administração do medicamento.

- O enfermeiro deve supervisionar o preparo e a administração de medicamentos realizados por técnicos e auxiliares de enfermagem.

- Seguir o protocolo da instituição quanto ao preparo de pacientes para exames ou jejum que possam interferir na administração do medicamento.

- Em casos de preparo de pacientes para exames ou jejum, não administrar nem adiar a administração de doses sem discutir conduta com o prescritor.

- Registrar adequadamente a omissão de dose e comunicar ao enfermeiro.

- Adequar os horários de administração dos medicamentos à rotina de uso já estabelecida pelo paciente antes da internação, sempre que possível.

- Evitar, dentro do possível, interações medicamento-medicamento e medicamento-alimento quando realizar o aprazamento de medicamentos.

- Discutir a prevenção das interações medicamentos as com a equipe multiprofissional (médico, farmacêutico e nutricionista).

- Seguir o protocolo institucional quanto à verificação das prescrições na passagem de plantão.

- Seguir o protocolo institucional quanto aos cuidados para que não haja a administração de medicamentos suspensos pelo médico.

- Padronizar o armazenamento adequado e a identificação completa e clara de todos os medicamentos que estão sob a guarda da equipe de enfermagem.

- Monitorar a temperatura da geladeira de acondicionamento de medicamentos, observando-se o parâmetro mínimo e máximo de temperatura diariamente, dirimindo dúvidas com o farmacêutico.

- Organizar local adequado para o preparo de medicamentos, preferencialmente sem fontes de distração e que permita ao profissional concentrar-se na atividade que está realizando.

- Seguir o guia de prevenção de incompatibilidades entre fármacos e soluções e guias de diluição de medicamentos.

- Solicitar revisão por um colega sempre que calcular doses para medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância.

- Fazer consultas ao farmacêutico e em fontes de informações atualizadas e idôneas em caso de dúvidas sobre o nome do medicamento, posologia, indicações, contra indicações, precauções de uso, preparo e administração.

- Utilizar instrumentos de medida padrão no preparo de medicamentos (ex: seringas milimetradas) para medir doses com exatidão.

- Seguir os sistemas de identificação do paciente e do leito ou sala de medicação estabelecidos nos protocolos institucionais.

- Padronizar equipamentos como bombas de infusão, limitando a variedade de opções.

- Seguir a prescrição de enfermagem para o uso de bombas de infusão para administração segura de medicamentos.

- Levar ao local, no horário de administração de medicamentos, apenas o que está prescrito a um único paciente, não fazendo uso de bandeja contendo diversos medicamentos para diferentes pacientes.

- Preparar o medicamento imediatamente antes da administração, a não ser que haja recomendação especial do fabricante para procedimento diferente.

- Manter registro adequado dos frascos de medicamentos preparados que serão armazenados (com data e horário da manipulação, concentração do medicamento, nome do responsável pelo preparo e validade).

- Administrar medicamentos por ordem verbal somente em caso de emergência, utilizando método de dupla checagem para administração com registro por escrito da ordem verbal.

- Registrar corretamente a administração do medicamento prescrito no prontuário do paciente, certificando que foi administrado ao paciente e evitando a duplicação da administração do medicamento por outro profissional.

- Informar ao paciente e à família sobre eventuais incidentes relacionados à terapia medicamentosa, registrando-o sem prontuário e notificando-os à Gerência de Riscos e/ou ao Núcleo de Segurança do Paciente.

- Comunicar ao paciente qual medicamento está sendo administrado e qual a sua ação no momento da administração. Devolver à farmácia as sobras de medicamentos não administrados pois estoques de medicamentos nas enfermarias são fonte importante de erros de administração

- Monitoramento e indicador para a administração segura de medicamento

Os eventos adversos relacionados à administração de medicamentos devem ser notificados ao Núcleo de Segurança do Paciente

6. ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES / CLIENTES

Não se aplica

7. RISCOS RELACIONADOS E AÇÕES PREVENTIVAS

O processo de uso de medicamentos envolve etapas críticas que, quando não adequadamente gerenciadas, podem resultar em erros com impacto direto na segurança do paciente. A identificação dos riscos e a adoção de ações preventivas são fundamentais para reduzir a ocorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos.

Riscos identificados:

- Identificação incorreta do paciente;
- Prescrição incompleta, ilegível ou desatualizada;
- Erros de dose, via, diluição, volume ou velocidade de infusão;
- Uso de abreviaturas, expressões vagas ou nomes de medicamentos semelhantes (LASA);
- Falhas na identificação de alergias;
- Dispensação incorreta de medicamentos, especialmente os potencialmente perigosos ou de alta vigilância;
- Falhas na comunicação durante os pontos de transição do cuidado (admissão, transferência e alta);
- Administração de medicamento diferente do prescrito ou fora do horário programado;
- Ausência de monitoramento e notificação de erros e eventos adversos.

Ações preventivas:

- Padronização institucional dos processos de prescrição, dispensação e administração de medicamentos;
- Utilização obrigatória de prescrição eletrônica com suporte clínico, sempre que disponível;
- Adoção dos identificadores institucionais do paciente em todas as etapas do processo;
- Realização de análise farmacêutica da prescrição antes da dispensação;
- Implantação de dupla checagem para medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância;
- Uso de listas institucionais de medicamentos padronizados, LASA e de alta vigilância;

- Educação permanente das equipes assistenciais sobre uso seguro de medicamentos;
- Fortalecimento da conciliação medicamentosa nos pontos de transição do cuidado;
- Monitoramento de indicadores e notificação sistemática de erros e eventos adversos ao Núcleo de Segurança do Paciente.

Essas ações contribuem para a redução de riscos, fortalecimento da cultura de segurança e qualificação da assistência, em conformidade com a Política Nacional de Segurança do Paciente e as diretrizes da Meta 3

8. INDICADOR

O indicador que será monitorado é o Taxa de erros na prescrição de medicamentos, que será evidenciado a partir da Triagem Farmacêutica da prescrição médica.

Nome do indicador	Taxa de erros na prescrição de medicamentos.
Objetivo do indicador	Monitorar a ocorrência de erros na atividade de prescrição de medicamentos.
Fórmula do indicador	nº medicamentos prescritos com erro x 100 nº total de medicamentos prescritos
Periodicidade mínima de verificação	Mensal
Explicação da fórmula	**Nº de medicamentos prescritos com erro:** são os medicamentos prescritos faltando dose, forma farmacêutica, via de administração, posologia, tempo de infusão, diluente, volume, velocidade de infusão, e abreviaturas contraindicadas.

	N° total de medicamentos prescritos: são todos os medicamentos prescritos em um determinado período de tempo.
Fonte de Informação	Prescrição (eletrônica, pré-digitada ou manual), protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
Coleta de dados	Preencher planilha para registro do número total de erros de prescrição e o número de medicamentos prescritos, utilizando a classificação de erros de prescrição. Totalizar os dados e aplicar a fórmula.
Observações	Em farmácias com sistemas informatizados, estes poderão ser preparados para emitir relatório com as informações necessárias para a aplicação da fórmula do indicador.
Responsável	Farmacêutico.

9. REFERÊNCIAS

1. Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos – Anexo 3. Ministério da Saúde.

2. Manual de orientações básicas para prescrição de médica. 2ª edição. Conselho Federal de Medicina. Brasília, 2011;

3. Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 2.217 de 27/09/2018 - Conselho Federal De Medicina. Brasília, 2019;

4. PORTARIA Nº 344, DE 12 DE MAIO DE 1998 - Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;

5. RESOLUÇÃO – RDC Nº 20, DE 5 DE MAIO DE 2011 - Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação;

6. LEI Nº 13.021, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 - Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas;

7. ISMP. Boletim: Medicamentos Potencialmente Perigosos de uso hospitalar – Lista atualizada 2019, volume 8, número 1, fevereiro 2019;

8. ISMP. Boletim: Nomes de medicamentos com grafia ou som semelhantes: como evitar erros?. volume 3, número 6, abril 2014;

9. ISMP. Boletim: Erros de medicação associados a abreviaturas, siglas e símbolos. volume 4, número 2, junho 2015;

10. ISMP. Boletim: Programa Nacional de Segurança do Paciente: Indicadores para avaliação da prescrição, do uso e da administração de medicamentos – parte II. volume 5, número 2, junho 2016;

11. SILVA, L. D. S. et al. Aprazamento de medicamentos por enfermeiros em prescrições de Hospital Sentinela. Brazil. Revista Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 722-730, set. 2013.

12. FERREIRA CR, DE OLIVEIRA S, PACHECO P, DE SOUZA S, DA SILVA L, OLIVEIRA J. O Cotidiano do

Enfermeiro no Aprazamento de Medicamentos. REAID [Internet]. 8set.2020 [citado 28dez.2020];93(31):e-20043. Available from: https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/634

13. MESQUITA, K. K. B. et al. Análise dos esquemas estabelecidos de administração de medicamentos analgésicos em terapia intensiva. Revista de Enfermagem da UFPE online, Recife, v.13, n. 2, p. 385- 393, fev. 2019.

10. ANEXO

ANEXO 1 - LISTA MEDICAMENTOS COM NOME ORTOGRÁFICO, FONÉTICO OU ASPECTO SEMELHANTES

Nome do Medicamento Concentração Apresentação Via de Acesso		Confundido com	Concentração Apresentação Via de Acesso
Ácido Fól**ico**	5 mg – Comprimido - VO	Ácido Fol**ínico**, sal Cálcico	15mg – Comprimido - VO 50mg - Injetável
Amicacina Sulfato	500mg – Ampola 2mL	**Gentami**cina Sulfato	80mg – Ampola 2mL
Ami**odarona**	50 mg/mL – Ampola	Ami**nofilina**	24mg/mL – Amp. 10mL
Anastrozol	1mg - Comprimido	**Le**trozol	2,5mg - Comprimido
Bupivacaína Cloridrato + glicose	0,5% + 8% - Ampola 4mL	**Levobupiva**caína com e sem Epinefrina	**0,5 % - Fra. ampola 20mL**
		Lidocaína + **Epinefrina**	2% + 1.200.00 - Fr. Amp. 20 mL
		Lidocaína 2% s/vaso	2% - Fr. amp. 20 mL
		Lidocaína	2% - Gel, Bisnaga 30g
		Lidocaína	10% - Spray Frasco

			50 mL
Cefa**lexina**	500mg - Cápsula 250mg - Suspensão Oral	Cefa**lotina** Sódica Tamponada	1g - Fr. amp
		Cefa**zolina**	1g - Fr. amp
Ceft**azidima**	1g - Fr. amp	Ceft**riaxona**	1g - Fr. amp.
Dactinomicina	0,5mg (500mcg) - Fr. amp	**Daunorubi**cina Cloridrato	20mg - Fr. amp.
		Doxorubicina	50mg – Fr. amp.
		Hidrocortisona, Succinato Sódico	100mg – Fr. amp. 500mg – Fr. amp.
		Prednisona	5 e 20 mg - Comprimido 08
		Metilprednisolona, Succinato sódico	125mg – Fr. amp. 500mg – Fr. amp.
		Dopamina	5mg/mL - Amp. 10mL
		Etilefrina	10mg - Amp. 1mL
		Norepinefrina Bitartarato	4mg - Amp. 4mL
		Heparina	5.000 UI - Fr. amp. 5 mL 5.000 UI – Amp. 0,25

			mL
		Idarrubicina	10mg - Fr. amp.
		Teniposido	50mg - Fr. amp.
		Fluoro-Uracil	500mg/10 mL - Amp. 10 mL
		Insulina NPH Humana	100 U – Fr. amp . 10mL
		Sevoflurano + Propilenoglicol	250 mL + 0,026% p/p – Fr. 250mL
		Tiabendazol	500mg – Comp.
		Imipenem + Cilastatina	500 mg + 500 mg – Fr. amp.
		Oxicodona	10mg - Comp. 20mg - Comp. 09
		Nalbufina	10 mg/mL - Amp. 1 mL
		Rocurônio	10 mg/mL - Fr. Amp. 5 mL
		Vincristina	1mg - Fr. amp.
		Vitamina K MM IV	10mg - Amp. 1 mL

ANEXO 2 - ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO NAS PRATELEIRAS - CAF E DISPENSAÇÃO

FCECON

CEFALOTINA 1g

Pó liófilo – Frasco-ampola EV



Lote:……

Validade: ……../……../……..

ANEXO 3 - MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS – PADRÃO FCECON

AGENTES ADRENÉRGICOS E DOPAMINÉRGICOS ENDOVENOSOS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Dobutamina	12,5 mg/mL	Solução Injetável
Dopamina	5 mg/mL	Solução Injetável
Epinefrina	1 mg/Ml	Solução Injetável
Etilefrina	10 mg/mL	Solução Injetável
Norepinefrina	4 mg/mL	Solução Injetável

ANALGÉSICOS NARCÓTICOS OPIÓIDES

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Fentanila Citrato	50mcg/hora (5,0mg) 100mg (10mg)	Adesivos Transdérmicos Adesivos Transdérmicos
Fentanila Citrato	0,0785mg/mL (eq. 0,05 mg de Fentanila base)	Injetável amp. 10 mL c/ conservante Injetável amp 2 mL s/ conservante
Fentanila Citrato + Droperidol	78,5mcg + 2,5mg	Ampola 2 mL
Petidina	50mg/mL	Injetável amp. 1 mL
Oxicodona, fosfato	10mg 20mg	Comp. Comp.
Codeína, fosfato	3mg/mL 30mg 30mg/mL	Sol. Oral 120 mL Comp. Amp. 2 mL
Metadona, Cloridrato	10 mg	Comp.
Morfina Sulfato – ação cronogramada	30mg 60mg 100mg	Cápsula Cápsula Cápsula
Morfina Sulfato	10mg/mL 10mg	Sol. Oral 60 mL Comp.

	30mg 10mg/mL 0,2mg/mL	Comp. Injetável amp. 1 mL Injetável amp. 1 mL
Nalbufina	10 mg/ml	Injet. Amp. 1 ml

ANESTÉSICOS GERAIS

Denominação Genérica	**Concentração/ Composição**	**Forma farmacêutica**
Cloridrato de Cetamina S (+)	50mg/mL	Injetável Fr. amp. 10 mL
Isoflurano	100 mL + 0,01% p/p	Frasco 100 mL
Sevoflurano	250 mL + 0,026% p/p	Frasco 250 mL
Tiopental Sódico	1g	Injetável Fr. amp.

ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS ENDOVENOSOS

Denominação Genérica	**Concentração/ Composição**	**Forma farmacêutica**
Propranolol	40 mg	Comprimido
Metoprolol, tartarato	5 mg	Solução Injetável

ANTIARRÍTMICOS ENDOVENOSOS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Amiodarona	50 mg/mL	Solução Injetável
Lidocaína (sem vasoconstritor)	2 %	Solução Injetável
Lidocaína + Epinefrina	2%	Solução Injetável

ANTITROMBÓTICOS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica/Descrição
Ácido acetil salicílico	100 mg	Comprimido
Enoxaparina sódica	20 mg/0,2 mL	Seringa pré-enchida
Enoxaparina sódica	40 mg/0,4 mL	Seringa pré-enchida
Heparina Sódica	5.000 UI	Fr. amp. 5 mL
Heparina Sódica	5.000 UI	Ampola, subcutânea 0,25 mL

BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Pancurônio Brometo	2mg/mL	Sol. Injet. amp. 2 mL
Rocurônio, Brometo	10 mg/mL	Fr. Amp. 5 mL
Sugamadex, sódico	100mg/mL	Fr. Amp. 2mL
Suxametônio Cloreto	500mg	Fr. amp. 10 mL

CONTRASTES RADIOLÓGICOS ENDOVENOSOS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
IOVERSOL / IOPROMIDA / IOBITRIDOL / IOPAMIDOL	Teor de iodo: 300 a 320mg/mL de iodo organicamente ligado (CONTRASTE NÃO IÔNIOCO)	Frasco ampola com 50mL solução injetável 68%
Meglumina Iotalamato (Conray)	252mg/ Ml	Frs. 50mL

MEDICAMENTOS USADOS EM DIABETES (Hipoglicemiantes Orais e Hormônios Injetáveis)

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma farmacêutica/Descrição
Glibenclamida	5 mg	Comprimido
Insulina humana NPH	100 UI/mL	Suspensão Injetável
Insulina Humana Regular	100 UI/mL	Suspensão Injetável

MEDICAMENTOS NA FORMA LIPOSSOMAL E SEUS CORRESPONDENTES EM FORMA CONVENCIONAL

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Anfotericina B Lipossomal	50 mg	Frasco-ampola
Anfotericina B	50 mg	Pó para solução injetável
Doxorrubicina Lipossomal	2 mg/mL	Suspensão Injetável
Doxorrubicina, cloridrato	50mg	Pó liófilo para solução injetável

NUTRIENTES EMPREGADOS EM SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma farmacêutica/Descrição
Aminoácidos + Glicose + Eletrólitos + Lipídios	900 Kcal/L	Bolsa Tricompartimentada

SUPLEMENTOS MINERAIS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica/Descrição
Cloreto de potássio	10%	Solução Injetável
Cloreto de sódio	10%	Solução Injetável
Gliconato de cálcio	10%	Solução Injetável
Magnésio, sulfato	10%	Solução Injetável

OUTROS NUTRIENTES

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma farmacêutica/Descrição
Glicose	50%	Solução Injetável

SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS

SUBSTITUTOS DO SANGUE E SOLUÇÕES PARA PERFUSÃO

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica/Descrição
Água para injeção	-	Solução Injetável (Frasco de 100mL ou volume superior)
Cloreto de Sódio	10 %	Solução Injetável

ANTIVIRAIS

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Aciclovir	200 mg	Comprimido
	250 mg	Pó liofilizado para solução injetável

ANÁLOGOS DE ÁCIDO FÓLICO

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Metotrexato (Oral,Inj)	2,5 mg	Comprimido
	50mg/500mg	

		Solução injetável
Pemetrexede R3	500 mg	Pó liofilizado para solução injetável

R3 Fármaco padronizado para mesotelioma (CID 10-C45)

ANTI-HISTAMÍNICO

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Prometazina, Cloridrato (Fenergan)	50mg 25mg	Injet., amp. 2 mL Comp.
Difenidramina, cloridrato	50mg/ml	Injet., amp. 1 mL

SEDATIVO AGONISTA ALFA-2 ADRENÉRGICO

SEDATIVOS DE AÇÃO MODERADA

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica
Dexmedetomidina	100 mcg/mL	Fr. amp. 2 mL
Midazolam, cloridrato	50mg/10ml	Injet. amp. 10mL
	5 mg/5ml 15mg/3ml	Injet. amp. 5mL Injet. amp. 3mL

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	10/12/2025	Elaboração do Protocolo da Meta 3 – Uso Seguro de Medicamentos

Elaboração: ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Assinado de forma digital por ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Dados: 2025.12.19 10:11:08 -04'00' **Coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente** Andréa Lima de Souza Marques	**Data:** 10/12/2025
Revisão: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:68376006215 Assinado de forma digital por GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:68376006215 Dados: 2025.12.23 13:08:08 -04'00'	**Data:**
Aprovação: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira – Diretora Técnica	**Data:**